

Fecha Última Actualización: 07-02-2023 11:40:03

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Rosa Aurora Pavez Ugarte

Edad : 47a 10m 3d

Dirección : Zenteno 246

Rut : 12.845.524-8

Fecha Nacto: 04/04/1975

Comuna : Valparaiso

N° Archivo : 2300476

Sexo : Femenino

Teléfono : 9 9999 9999

N° Epicrisis

340444

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 06/01/2023 22:48

Días Estadía: 32

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 07/02/2023 10:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hepatitis aguda

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

F. INGRESO HCVB : 03/01/23

F. INGRESO UCIM HCVB : 06/01/23

F. INGRESO UPC CASR : 06/01/23

F. INGRESO SALA BÁSICA CASR: 28/01/23

NOMBRE: Rosa Aurora Pavez Ugarte

EDAD: 47 años

RUT : 12845524-8

DOMICILIO: Zenteno 246 Cerro Baron, Valparaiso

FONO DE CONTACTO: Esposo Carlos 954710025; Hermana Elena 979885208

ANTECEDENTES

Médicos. DM2 NIR, Dislipidemia.

FÁRMACOS: Atorvastatina 20 mg c/ 24 hrs; Metformina 850 mg c/ 24 hrs.

ALERGIAS: Antiespasmódicos.

HÁBITOS: OH: NO, Tabaco : NO , Drogas : NO.

VACUNAS: 4 dosis COVID

HISTORIA INGRESO

Paciente refiere cuadro de 1 mes de evolución caracterizado por dolor abdominal epigástrico asociado a náuseas e inapetencia, además familiares perciben ictericia. Consulta en APS y posteriormente en HCVB. Laboratorio de 14/12/22 mostró hiperbilirrubinemia predominio directa, transaminasas elevadas GOT 1245 GPT 691 Na 133 INR 1,39. Se tomaron exámenes de serología viral y es dada de alta.

Nuevamente consulta el día 03/01/2023 por persistencia dolor abdominal, náuseas, vómitos, con hiperbilirrubinemia directa al alza, transaminasas 2000. Se rescatan exámenes de laboratorio IgM anticore VHB, VHC, CMV IgM y VHA no reactivos. Se pide laboratorio de etiología autoinmune.

Evaluada por gastroenterología concluyeron hepatitis autoinmune e indican terapia corticoidal con hidrocortisona 100 mg c/8 hr. Se indicó adicionalmente 17 dosis de N-Acetilcisteína.

Se solicitó COVID que resultó positivo 04/01/23. Evaluada formalmente por Infectólogo (Dr. Wilson) quien indica completar aislamiento de contacto y gotitas hasta Domingo 08/01/2023, descrita asintomática, sin opacidades al TAC de tórax. Ingresada

Fecha Epicrisis : 07/02/2023 11:40

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 07-02-2023 11:40:03

Página 2 de 5

a UCIM (UPCA intermedio) 06/01/23, para vigilancia y manejo en aislado. Durante estadía en UCIM evoluciona estacionaria aunque sin deterioro clínico significativo. Hemodinamia estable bien perfundida. Destaca alteración de coagulación, sin evidencia de sangrado clínico ni en exámenes; se maneja con Vitamina K EV. Sin otras fallas orgánicas. Desde el punto de vista de conciencia se describe vigil, cooperadora, orientada en tiempo y espacio con Glasgow 15. Flapping (-).

ACs ANA Hep 2: (+), Dilución 1:320, patrón nuclear homogéneo.

AC. AMA: (-) 1/40

ASMA : (-) 1/40.

AC.Anti DNA : (-) 1/20

ANTI CCP3: 2.0 (-)

Complemento C3: 31 mg/dl (bajo)

Complemento C4: 5.7 mg/dl (bajo)

Perfil ENA (-)

IgG : 5590 mg/dl

IgA 314 mg/dl

IGM : 149 mg/dl

Ferritina : 6859.70 ng/ml

IMÁGENES.

TAC AP: (04-01-23) Signos tomográficos de daño hepático crónico. Hígado con impregnación heterogénea con el medio de contraste y edema periportal difuso, inespecífico. Engrosamiento de paredes y edema perivesicular, inespecífico.

EXAMEN FÍSICO DE INGRESO

Buenas condiciones generales. Manteniendo vigilia espontánea, orientada, atenta. Pupilas isocóricas reactivas.

Ictericia de piel y mucosas.

CRT 3 segundos. Tibia a distal.

Ventilando simétrico sin uso de musculatura accesorio.

Abd: BD sin signos de irritación peritoneal.

EEII: Edema bilateral leve sin signos de TVP.

LABORATORIO DE INGRESO (06/01/2023)

Creatinina 0,68 mg/dl, Uremia 24 mg/dl, Potasio 2.5 mmol/l, Sodio : 132 mmol/L, Magnesio: 1.7 mg/dl, Bili total: 19.67 mg/dl, BiliD: 12.94 mg/dl GOT 1270 U/L GPT 908 U/L, INR (06/01) Incoagulable, Hto 31.4 Hb 11.1 Plaquetas 132.000 GB: 11800. PCR 9.5

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

Daño hepático (Obs crónico) ¿ Sospecha hepatitis autoinmune

MELD 38

Falla hepática Obs ACLF

CLIF-C 47 (Mortalidad 22% a 1 mes, 38% a 3 meses, 43% a 6 meses, 52 % a 1 año)

Hiponatremia hiposmolar normovolémica

Hipokalemia en corrección.

Infección respiratoria alta COVID + (04/01/23) asintomática

DM2 NIR

Dislipidemia

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS:

Hemodinámico: Hemodinámicamente estable durante estadía hospitalaria, sin necesidad de DVA. Clínicamente evoluciona con discreto aumento de VEC determinado por edema periférico, con buena respuesta a diuréticos. Actualmente impresiona euvolémica, con dosis baja de diurético de asa. Control seriado de hemoglobina, sin gatillotransfusional. Actualmente en rangos de anemia leve. Sin exteriorización de sangrado.

Ventilatorio: Se mantiene con buena mecánica ventilatoria, sin requerimientos de oxígeno complementario ni otra necesidad de soporte ventilatorio.

Neurológico: Evoluciona sin encefalopatía hepática demostrable. Sin conflicto.

Fecha Epicrisis : 07/02/2023 11:40

Página 2 de 5

Gastroenterológico: DHC con estigmas de hipertensión portal. Actualmente cursando hepatitis aguda grave secundaria a HAI por serología. Inmunosuprimida con Prednisona, inicialmente 35 mg/día, actualmente 30 mg/día. Panel de hepatopatías autoinmunes (-). Seguimiento de pruebas hepáticas diarias, estables en contexto de su alteración inicial, con tendencia a la baja, actualmente bilirrubina total en 10.84, GOT 212, GPT 186, INR 1.57, LDH 357, FA 387, GGT 212. Estudio imagenológico (TAC AP 07/01) con 2 Lesiones Focales Hepáticas, 1 de ellas sugerente de HCC y la otra no caracterizable. AFP 12. Biopsia percutánea sin incidentes, pendiente informe, preinforme destaca hepatitis de interfase, necrosis en puente, sin infiltrado plasmocitario con posibilidades diagnósticas HAI vs DILI. Sin asterixis, 2 deposiciones diarias con PEG (lactulosa mal tolerada). Pendiente estudio con RMN, se realiza en su defecto TAC Abdomen Trifásico 06/02, informa cambios morfológicos de daño hepático crónico asociado a leve ascitis y circulación colateral porto sistémica, nódulo hipervascular en el segmento VII LIRADS 3, probablemente un shunt, y no se demuestran lesiones focales hepáticas sospechosas de un hepatocarcinoma. Pendiente medición de Tiopurina Metiltransferasa (TMPT) para inicio de AZA. Pendiente estudio EDA. Estudio preTHO (pre-trasplante): Ecocardio OK, Rx Cavidades paranasales OK.

Manejo del Dolor: Evoluciona sin dolor, actualmente con fármacos SOS. Sin necesidad de rescates.

Hematología: paciente cursa bicitopenia secundario a patología hepática. Anemia leve normocítica arregenerativa, cinética de hierro con sideremia 158 (N), UIBC 25 (bajo), Ferritina 1600 (alto), B12: 1300. Además, cursa con trombocitopenia persistente, último en 58000, sin exteriorización de sangrados.

Renal/Medio Interno: Sin falla renal, cursa con hiponatremia e hipokalemia leves durante hospitalización. Hiponatremia obs. dilucional vs. SIADH, en tratamiento con furosemida. Hipokalemia leve, hoy se carga EV. Mantener seguimiento de función renal. Durante hospitalización cursa con hipofosfatemia, con mejoría espontánea.

Infeccioso: Cursa con Influenza (+) asintomática. Se inicia Oseltamivir (FI 19/01), completa 5 días. cursa cuadro de 1 semana de evolución de fatiga y tos no productiva, con signología obstructiva, recibe 1 semana de B. de ipratropio.

Metabólico: Antecedente de DM2. Control HbA1c 4.1% (11/01). Con esquema de insulina correccional tiene regular control glicémico durante la hospitalización, 01/02 se inicia insulina basal, con ajustes posteriores en ambulatorio en su consultorio.

Endocrinología: En contexto de hipocalcemia se solicitó VitD, bajo nivel normal. Se inicia carga de VitD 50.000 UI/semanal y Calcio/Vit D VO/diario.

Profilaxis: Prevención HDA con IBP, profilaxis PCP con TMP/SMX trisemanal. Se inició Calcio/VitD.

Ginecología: En útero muestra una imagen de menor realce nodular próxima al fondo, de 7x 10 mm no caracterizable. Evaluado por especialidad, impresiona adenomiosis, indicación de control SOS en caso de sangrado ginecológico.

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

Vigil, orientada, atenta. Pupilas isocóricas reactivas.

Ictericia de piel y mucosas. Mucosas húmedas, llene capilar 2 seg. Tibia a distal.

Ventilando simétrico sin uso de musculatura accesoria. RR2T NAS. MP (+) bilateral con crépitos bibasales.

Abd: RHA (+). BD. Doloroso a la palpación profunda en hipocondrio derecho y epigastrio. Sin signos de irritación peritoneal.

Pulsos periféricos (+++)

EEII: sin edema sin signos de TVP. Asterixis (-).

EXÁMENES DE LABORATORIO RECIENTES

06/02: Hb 10.7, Hcto 33.3, GB 8.68, RAN 5.6, PLQ 123, TP seg 17.1, INR 1.51, TTPA seg 36.6, GSV pH 7.572, CO2 29.3, HCO3 26.4, Albúmina 1.4, B T 7.69, BD 5.45, FA 348, GGT 210, GOT 152, GPT 137, Ca 7.9, CaC 9.98, Crea 0.64, BUN 12.8, P 2.8, LDH 351, Mg 1.8, ELP 132/3.09/103

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

- Hepatitis aguda grave MELD-Na: 28 Obs ACLF

- Debut HAI.

- LFHs: 5mm Obs HCC + 14x16mm no caracterizable

- Bicitopenia en observación Obs 2ria a Insuficiencia hepática.

Fecha Última Actualización: 07-02-2023 11:40:03

Página 4 de 5

- Anemia moderada normocítica
- Trombocitopenia leve
- Hipokalemia leve en tratamiento
- Hiponatremia moderada Obs. VEC aumentado vs. SIADH, en tratamiento
- Hipofosfemia recuperada
- Usuaria crónica de corticoides
 - Hiperglicemia esteroideal
- Adenomiosis no complicada
- Antecedentes: DM2 NIR, DLP

Int. Hosiasson / Dr. Leiva / Dr. Sarfatis
Medicina Interna

Diagnóstico de Egreso

Hepatitis Autoinmune - Falla Hepática Aguda
Insuficiencia Hepática Crónica -
Anemia De Tipo No Especificado -
Trombocitopenia Secundaria - Secundaria A Daño Hepático Crónico

Condición de Egreso Alta Otro Destino

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en buenas condiciones generales, afebril, normotensa, eupneica. Sin dolor franco, epigastrio sensible a la palpación. Sin otros síntomas. Tolerando vía oral. Diuresis (+). Deposiciones (+).

Plan Post Alta

INDICACIONES AL ALTA

Reposo relativo

Régimen: 200 g de CHO, hiposódico (menos de 2 g de sodio diarios).

Fármacos

Prednisona 25 mg 1 vez al día vía oral.

Cotrimoxazol Forte (TMP 800 ng + SMX 160mg) vía oral tres veces a la semana (Lunes-Miércoles-Viernes)

Omeprazol 20 mg al día vía oral.

Calcimax D3 400. 1 Comprimido al día vía oral.

PEG 17g, diluir en 200 mL de agua al día vía oral, para 2-3 deposiciones diarias.

Bonavid 300.000 UI/2 ml, 10 gotas vía oral semanal 2/6. Recibir los jueves.

Paracetamol 1g cada 8 horas vía oral SOS, en caso de dolor o fiebre.

Insulina NPH basal 8 UI/día SC en las mañanas.

Exámenes

Control de exámenes Miércoles: Electrolitos plasmáticos, Celdyn, Pruebas de coagulación (INR y TTPA), Perfil hepático.

Imágenes

Pendiente: RMN y EDA (a programar por gastroenterología/hepatología).

Controles

Control en consultorio para evaluación diabetología, educación insulino terapia y administración de Bonavid semanal.

Controles con Gastroenterología/Hepatología: Hospital Van Buren se haría cargo de controles con gastroenterología de su hospital, en caso que esto no se realice, comunicarse con adominguez.gastro@gmail.com (Hepatología Hospital Sotero del Río)

Pendientes

Rescatar resultado de Biopsia Hepática.

Pedir Tiopurina Metiltransferasa, en caso de beneficiarse de Azatioprina. Determinar según Biopsia.

Evaluar necesidad de enlistar a trasplante hepático

Int. Hosiasson / Dr. Leiva / Dr. Sarfatis
Medicina Interna

Fecha Epicrisis : 07/02/2023 11:40

Página 4 de 5

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico, 200 Gramos De Carbohidratos

Medicamentos : Prednisona 20 Mg 25 Mg Al Día Por Vía Oral
Paracetamol 500mg 2 Comprimidos Vía Oral Cada 8 Horas Sos, En Caso De Dolor
Omeprazol 20mg 1 Comprimido Al Día Vía Oral
Metformina 850 Mg Comp. 1 Comprimido Diario Vía Oral
Insulina Ultra Lenta 100uiml 3ml(Lantus) 8ui Al Día Por Vía Subcutánea En La Mañana (Antes Del Desayuno)
Cotrimoxazol Forte 1 Comprimido Trisemanal. Lunes-Miércoles-Viernes.

Controles

Nicolás Berrios Caro

STAFF

Bec. Felipe Leiva Olmos

Becado/Residente



Alberto Sarratis Feige

Médico Tratante (Staff)